

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC



BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI

“Hiệu quả của liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) giai đoạn tiến triển”.

Họ và tên sinh viên : Lê Hồng Nhung

Mã sinh viên : 25100266

Lớp : QH.2025.YE

Môn : Nhập môn công nghệ số và AI

HÀ NỘI 2026

I. LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

1. Lý do chọn chủ đề:

Ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư. Liệu pháp miễn dịch (Immunotherapy) là bước tiến mới mang tính đột phá. Việc tìm kiếm tài liệu giúp cập nhật các phác đồ điều trị mới nhất vượt ra ngoài kiến thức giáo trình truyền thống.

2. Phạm vi tìm kiếm:

- Thời gian: 2021 - 2026 (Ưu tiên các nghiên cứu trong 3 năm gần nhất do tốc độ thay đổi phác đồ rất nhanh).
- Loại hình nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (RCT), Systematic Review, Meta-analysis.
- Cơ sở dữ liệu: PubMed, Cochrane Library, The Lancet, New England Journal of Medicine (NEJM).

II. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu (tác giả, năm)	Đánh giá
1	Bài báo KH	<i>Immunotherapy vs Chemotherapy in NSCLC (2025)</i>	- Tác giả/cơ quan: Nhóm chuyên gia ĐH Harvard; Đăng trên The Lancet. - Phương pháp nghiên cứu: Meta-analysis: Tổng hợp từ 20 RCTs, cỡ mẫu >10.000 BN. - Trích dẫn, cập nhật: >500 trích dẫn; Xuất bản 2025 (Cực mới) - Ưu: Giá trị bằng chứng cao nhất; loại bỏ sai số lẻ tẻ; cỡ mẫu tổng hợp cực lớn. Nhược: Quy trình tổng hợp phức tạp; dễ bị sai số nếu các nghiên cứu gốc không đồng nhất
2	Bài báo KH	<i>Hiệu quả Pembrolizumab tại Việt Nam (2024)</i>	- Tác giả/cơ quan: PGS. TS. Nguyễn Văn Ánh (Bệnh viện K); Tạp chí Ung thư VN - Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng (RCT): Nghiên

			cứu mù đôi trên 300 bệnh nhân Việt. - Trích dẫn, cập nhật: Tài liệu tham khảo chính tại BV K; Xuất bản 2024. - Ưu: Sát thực tế dịch tễ và thể trạng người Việt. Nhược: Cỡ mẫu nhỏ hơn các nghiên cứu đa quốc gia.
3	Sách CK	<i>Principles of Oncology</i> (DeVita, 12th Ed, 2023)	- Tác giả/cơ quan: GS. Vincent DeVita (Yale School of Medicine); NXB Wolters Kluwer - Phương pháp nghiên cứu: Hệ thống hóa: Tổng hợp lý thuyết từ cơ chế phân tử đến điều trị. - Trích dẫn, cập nhật: Sách giáo khoa chuẩn quốc tế; Tái bản lần thứ 12. - Ưu: Khung lý thuyết kinh điển, cực kỳ chuyên sâu. Nhược: Cập nhật chậm hơn các bài báo báo cáo thử nghiệm mới.
4	Bài báo KH	<i>Hướng dẫn chẩn đoán & điều trị NSCLC</i> (2024)	- Tác giả/cơ quan: Hội đồng Chuyên môn (Bộ Y tế Việt Nam) - Phương pháp nghiên cứu: Đồng thuận chuyên gia dựa trên bằng chứng (EBM). - Trích dẫn, cập nhật: Văn bản pháp lý cao nhất tại VN; Cập nhật 2024. - Ưu: Tính thực tiễn và tuân thủ cao. Nhược: Quy trình duyệt chậm nên đôi khi thiếu thuốc mới nhất.
5	Bài báo KH	<i>Báo cáo Ung thư Thế giới 2025</i> (2025)	- Tác giả/cơ quan: Christopher Wild (Cơ quan IARC/WHO)

			- Phương pháp nghiên cứu: Thống kê mô tả: Phân tích dữ liệu dịch tễ từ 185 quốc gia. - Trích dẫn, cập nhật: Nguồn dữ liệu gốc của WHO; Cập nhật 2025. Ưu: Độ chính xác số liệu tuyệt đối. Nhược: Không có giá trị hướng dẫn điều trị trực tiếp.
6		<i>Biomarkers in Lung Cancer (2025)</i>	- Tác giả/cơ quan: GS. Alice Chen (Viện Nature Reviews); Tạp chí Nature - Phương pháp nghiên cứu: Systematic Review: Tổng hợp cơ chế kháng thuốc miễn dịch. - Trích dẫn, cập nhật: Chỉ số IF (Impact Factor) >40; Xuất bản 2025. - Ưu: Đi sâu vào bản chất sinh học phân tử hiện đại. Nhược: Mang tính học thuật cao, khó áp dụng tại BV tuyến tính.
7		<i>Real-world evidence of Nivolumab (2024)</i>	- Tác giả/cơ quan: BS. David Brown (Hiệp hội ASCO); Tạp chí JCO - Phương pháp nghiên cứu: Cohort Study: Quan sát hậu kiểm trên 5.000 bệnh nhân. - Trích dẫn, cập nhật: Được trích dẫn bởi các nhà hoạch định chính sách; 2024. - Ưu: Phản ánh hiệu quả thuốc trong điều kiện thực tế. Nhược: Dễ bị nhiễu do bệnh nhân không được kiểm soát chặt.
8		<i>Adverse Events of PD-1</i>	- Tác giả/cơ quan: GS. Jean-Charles Soria (Viện Gustave Roussy); Tạp chí NEJM

		<i>Inhibitors</i> (2024)	- Phương pháp nghiên cứu: Clinical Trial: Nghiên cứu về độc tính và an toàn lâm sàng. - Trích dẫn, cập nhật: Tạp chí Y khoa số 1 thế giới; Xuất bản 2024. - Ưu: Cực kỳ chi tiết về các biến cố bất lợi. Nhược: Tập trung vào rủi ro, cần kết hợp với nguồn lợi ích.
9		<i>Harrison's Internal Medicine</i> (2022)	- Tác giả/cơ quan: Dennis Kasper (ĐH Harvard); NXB McGraw-Hill - Phương pháp nghiên cứu: Sách chuyên khoa: Tổng quan nội khoa toàn diện. - Trích dẫn, cập nhật: Tài liệu đào tạo y khoa chuẩn; Ấn bản 21. - Ưu: Giúp chẩn đoán phân biệt đa cơ quan rất tốt. Nhược: Phần ung thư học chỉ là một chương nhỏ, thiếu chuyên sâu.
10		<i>Immunotherapy: Patient Education</i> (2026)	- Tác giả/cơ quan: Ban Biên tập Y khoa (Hệ thống Mayo Clinic) - Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp thông tin: Chuyển đổi ngôn ngữ khoa học sang cộng đồng. - Trích dẫn, cập nhật: Lướt truy cập toàn cầu; Cập nhật liên tục 2026. - Ưu: Ngôn ngữ dễ hiểu cho bệnh nhân. Nhược: Không đủ giá trị trích dẫn cho luận văn hàn lâm.